PROYECTO DE LEY

Ley de abordaje sanitario de los consumos: reforma de la Ley 23.737 y acceso regulado bajo supervisión médica

Deroga el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley 23.737 (tenencia para consumo personal), crea un régimen de acceso regulado bajo supervisión médica, solo por canales con control sanitario, a las sustancias que fija la propia ley sobre la base de una evaluación sanitaria independiente con revisión periódica, y afecta las tasas y multas del régimen a prevención y tratamiento.

Propuesta 81: Salud mental y adicciones: tratar, no perseguir
Cuándo: Fase I · año 1: consulta popular vinculante en el primer semestre de 2028
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. No crea tributos: las tasas de habilitación y fiscalización son retributivas de servicios. Se somete a consulta popular vinculante: si la mayoría de los votos válidos la aprueba, se convierte en ley en forma automática (art. 40 de la Constitución Nacional).

FUNDAMENTOS

La Ley N° 23.737 castiga con prisión la tenencia de estupefacientes para uso personal. Esa respuesta penal no reduce el consumo, aleja de los servicios de salud a quienes necesitan ayuda y consume recursos policiales y judiciales que deberían dirigirse contra las redes de narcotráfico. La Ley N° 26.657 establece que las adicciones deben abordarse como parte de las políticas de salud mental. El presente proyecto deroga el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley N° 23.737 y crea un régimen de acceso regulado, bajo supervisión médica, a las sustancias que la propia ley enumera sobre la base de una evaluación sanitaria independiente, con revisión periódica. La provisión se hace solo por canales con control sanitario y trazabilidad, a personas mayores de edad inscriptas en un registro, nunca por el mercado libre, y sin publicidad. El régimen sigue la experiencia del registro nacional previsto en la Ley N° 27.350 para el uso medicinal del cannabis. Quien desvíe sustancias fuera de esos canales sigue sometido a las penas de la Ley N° 23.737. Las tasas y multas del régimen, junto con los recursos que hoy se destinan a perseguir el consumo, se afectan a prevención y tratamiento.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece el abordaje sanitario de los consumos de sustancias: deroga la punición de la tenencia para consumo personal, crea un régimen de acceso regulado bajo supervisión médica a las sustancias que enumera y afecta recursos a la prevención y al tratamiento.

ARTÍCULO 2°.- Principios. La aplicación de la presente ley se rige por los principios de salud pública, reducción de daños, prevención, protección de niñas, niños y adolescentes, y provisión exclusiva por canales con control sanitario. Los consumos problemáticos se abordan como parte de las políticas de salud mental, conforme el artículo 4° de la Ley N° 26.657. Ninguna disposición de esta ley habilita la venta libre de las sustancias comprendidas.

Capítulo II – Reforma de la Ley N° 23.737

ARTÍCULO 3°.- Derogación. Derógase el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley N° 23.737.

ARTÍCULO 4°.- Medidas de seguridad. Deróganse los artículos 17, 18 y 21 de la Ley N° 23.737, que prevén las medidas de seguridad curativas y educativas aplicables a la tenencia de estupefacientes para uso personal del segundo párrafo de su artículo 14. La persona que lo solicite puede acceder a tratamiento en el sistema de salud conforme la Ley N° 26.657.

ARTÍCULO 5°.- Aplicación en el tiempo. La derogación del artículo 3° se aplica a los procesos en trámite y a las condenas dictadas, conforme el artículo 2° del Código Penal.

ARTÍCULO 6°.- Tenencia dentro del régimen. La adquisición, la tenencia y el consumo de las sustancias del Anexo I por personas inscriptas, obtenidas por los canales autorizados y en las cantidades que fije la reglamentación, no constituyen delito.

ARTÍCULO 7°.- Desvío. Quien produzca, provea, comercialice o entregue sustancias del Anexo I fuera de los canales autorizados, o desvíe hacia ellos sustancias obtenidas en el régimen, queda sujeto a las penas que la Ley N° 23.737 establece para esas conductas, sin perjuicio de las sanciones administrativas de la presente ley.

Capítulo III – Acceso regulado bajo supervisión médica

ARTÍCULO 8°.- Sustancias comprendidas. El régimen de acceso regulado comprende las sustancias enumeradas en el Anexo I, que forma parte de la presente ley, en las formas y con los esquemas que allí se indican, definidos sobre la base del informe de la evaluación sanitaria independiente encargada por el Ministerio de Salud. La incorporación o la exclusión de una sustancia solo puede disponerse por ley.

ARTÍCULO 9°.- Revisión periódica. Cada tres (3) años, la autoridad de aplicación encarga una nueva evaluación sanitaria independiente del régimen y de cada sustancia, con las mismas garantías de independencia y publicidad que la primera, y remite el informe al Congreso de la Nación con sus propuestas de modificación.

ARTÍCULO 10°.- Suspensión precautoria. Ante una alerta sanitaria grave y fundada, la autoridad de aplicación puede suspender en forma precautoria la provisión de una sustancia del Anexo I por un plazo de hasta ciento ochenta (180) días, e informa al Congreso de la Nación dentro de los diez (10) días. La suspensión solo puede prolongarse por ley.

ARTÍCULO 11°.- Personas usuarias. Pueden acceder al régimen las personas mayores de dieciocho (18) años, con residencia en el país, inscriptas en el Registro Nacional de Acceso Regulado que lleva la autoridad de aplicación, previa evaluación por un médico inscripto. El Registro sigue el modelo del registro nacional previsto en el artículo 8° de la Ley N° 27.350 y se rige por la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 12°.- Supervisión médica. El médico inscripto realiza una evaluación inicial, informa a la persona sobre los riesgos de la sustancia, fija el esquema de acceso dentro de los límites de la reglamentación, hace controles periódicos y, ante un consumo problemático, ofrece la derivación a tratamiento. Los datos se registran en la historia clínica.

ARTÍCULO 13°.- Canales de provisión. Las sustancias del Anexo I solo pueden dispensarse en farmacias y establecimientos de salud habilitados para el régimen por la autoridad de aplicación, a personas inscriptas, en las cantidades y con la periodicidad que fije la reglamentación. Está prohibida su venta o entrega por cualquier otro medio y su cesión a terceros.

ARTÍCULO 14°.- Producción, importación y trazabilidad. Las sustancias solo pueden ser producidas o importadas por personas habilitadas por la autoridad de aplicación, con los requisitos de calidad de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y un sistema de trazabilidad desde la producción hasta la dispensa. La producción de cannabis y sus derivados se rige, además, por la Ley N° 27.669.

ARTÍCULO 15°.- Publicidad. Se prohíben la publicidad, la promoción y el patrocinio, directos o indirectos, de las sustancias del Anexo I y de quienes las producen o dispensan.

ARTÍCULO 16°.- Sanciones administrativas. El incumplimiento de la presente ley por las personas habilitadas se sanciona, según su gravedad y previo sumario, con: a) apercibimiento; b) multa de diez (10) a diez mil (10.000) salarios mínimos, vitales y móviles; c) suspensión de la habilitación de hasta un (1) año; o d) cancelación de la habilitación. Las sanciones pueden acumularse.

ARTÍCULO 17°.- Tasas. La autoridad de aplicación fija tasas retributivas por la habilitación y la fiscalización de productores, importadores y canales de provisión. La inscripción de las personas usuarias es gratuita.

Capítulo IV – Prevención y tratamiento

ARTÍCULO 18°.- Cuenta especial. Créase una cuenta especial con destino exclusivo a programas de prevención de consumos y de tratamiento de consumos problemáticos, que se integra con: a) las tasas del artículo 17; b) las multas del artículo 16; y c) los créditos que le asigne la ley de presupuesto conforme el artículo 19. La cuenta especial queda expresamente excluida de la facultad de disolver o modificar fondos fiduciarios y fondos con destino específico prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y de cualquier otra facultad delegada o reglamentaria de igual alcance.

ARTÍCULO 19°.- Reasignación. El Jefe de Gabinete de Ministros identifica cada año, en el proyecto de ley de presupuesto, los créditos que se destinaban a la persecución penal de la tenencia para consumo personal y propone su reasignación a la cuenta especial del artículo 18.

ARTÍCULO 20°.- Prevención. La Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud ejecuta los programas financiados con la cuenta especial, con prioridad en la prevención en escuelas y comunidades, la atención en centros de salud y hospitales generales y la reducción de daños.

Capítulo V – Disposiciones generales

ARTÍCULO 21°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud, que coordina con el Ministerio de Justicia y Seguridad la prevención del desvío y la persecución de las redes de narcotráfico.

ARTÍCULO 22°.- Información pública. La autoridad de aplicación publica cada año, sin datos personales, la cantidad de personas inscriptas por sustancia y jurisdicción, los canales y productores habilitados, las sanciones aplicadas, los desvíos detectados, los indicadores de consumo y de atención, y la ejecución de la cuenta especial.

ARTÍCULO 23°.- Financiamiento. Los gastos de aplicación de la presente ley se atienden con los recursos de la cuenta especial del artículo 18 y con los créditos asignados a la autoridad de aplicación en la ley de presupuesto vigente, mediante reasignación de partidas y sin aumento del gasto total. Las erogaciones adicionales se incluyen a partir de la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 24°.- Implementación gradual. El régimen del Capítulo III comienza a funcionar dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la reglamentación, en forma gradual por sustancia, en el orden y con los plazos que indique el Anexo I.

ARTÍCULO 25°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su publicación.

ARTÍCULO 26°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 27°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Anexo I – Sustancias comprendidas

ARTÍCULO 28°.- Anexo I. [A completar con las conclusiones del informe final de la evaluación sanitaria independiente.] Para cada sustancia: a) denominación y formas de presentación admitidas; b) esquema de acceso: cantidad máxima por persona y por período, y frecuencia mínima de control médico; c) canales de provisión habilitados; d) orden y plazo de incorporación al régimen; y e) indicadores de seguimiento para la revisión del artículo 9°.